

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

galcanezumab 120mg/mL

(앰겔러티120밀리그램/밀리리터프리필드펜주, 시린지주, 한국윙리(유))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1펜 또는 관 중 galcanezumab 120mg/mL

☐ **효능 효과 :**

- 성인에서의 편두통의 예방

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2022년 제5차 약제급여평가위원회: 2022년 5월 12일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2021년 8월 27일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 ‘성인에서의 편두통의 예방’에 허가된 약제로, 월 편두통 일수의 유의한 감소 등의 임상적 필요성이 인정되며, 경제성평가 결과 비용효과비가 기존 유사 심의결과 범주 안에 포함되므로 급여의 적정성이 있음.

- 다만, 신청품의 경제성평가 분석 시 효용 추정의 불확실성이 존재하여 비용효과비의 상향 가능성이 있으므로 이를 고려한 약가 협상이 필요함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘성인에서의 편두통의 예방’에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제로 topiramate, divalproex, flunarizine, nadolol 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ‘성인에서의 편두통의 예방’에 허가 받은 칼시토닌유전자연관펩티드(CGRP) 단클론항체로, 편두통 통증 병태생리에서 중요한 기전인 삼차신경혈관계 활성화에서 가장 중요한 역할을 하는 신경전달물질인 CGRP 리간드에 결합하여 작용함.
- 신청품은 교과서¹⁾²⁾에서 칼시토닌유전자연관펩티드(CGRP) 단클론항체로 유효성 및 안전성 모두를 입증한 새로운 편두통 특이적인 예방 약제로 소개되며, 국내·외 임상진료 지침³⁾⁴⁾에서 성인 삼화 및 만성편두통 환자의 편두통 예방약제로 권고됨.
- [CONQUER]⁵⁾ 과거 10년 내 2~4종의 예방 약제에 실패한 삼화 또는 만성편두통 성인 환자 462명을 대상으로 한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 위약 대조 3b상 시험 결과, 1차 평가지표인 3개월간의 월 편두통 일수는 위약 대비 신청품군에서 평균 3.1일 더 감소하였음(신청품군 기저치 13.4일에서 평균 4.1일 감소, 위약군 기저치 13.0일에서 평균 1.0일 감소; 95% CI - 3.9 to - 2.3; $p < 0.0001$; effect size=0.72).
 - 만성편두통 하위군(193명) 분석에서 1차 평가지표인 3개월간의 월 편두통 일수는 위약 대비 신청품군에서 평균 3.7일 더 감소하였으며(95% CI - 5.2 to - 2.2; $p < 0.0001$; effect size=0.70), 주요 2차 평가지표인 기저 대비 월 편두통 일수가 50% 이상, 75% 이상 감소된 환자의 평균 비율은 위약 대비 신청품군에서 더 높게 관찰됨(50% 이상 반응률 $p < 0.0001$, 75% 이상 반응률 $p = 0.019$).
 - 치료 후 이상 반응 유형 및 횟수는 위약과 신청품군이 유사하였음.
- [REGAIN]⁶⁾ 만성편두통 성인 환자 1,113명을 대상으로 한 위약 대조, 이중맹검, 무작위 배정 3상 시험 결과, 1차 평가지표인 3개월간의 월 편두통 일수는 위약 대비 신청품 120mg 투여군에서 평균 2.1일 더 감소하였음(placebo - 2.7, galcanezuamb 120mg - 4.8, 240mg - 4.6)($p < 0.001$ for each dose compared to placebo).
 - 주요 2차 평가지표인 기저 대비 월 편두통 일수가 50% 이상, 75% 이상 감소된 환자의 평균 비율은 위약 대비 신청품군에서 더 높게 관찰됨(50% 이상 반응률 both doses $p < 0.001$, 75% 이상 반응률 120mg $p < 0.05$, 240mg $p < 0.001$).

- 발열을 제외한 내약성 또는 안전성 결과에서 위약과 신청품 120mg 투여군 사이의 임상적으로 유의한 차이는 없었음.
- 관련 학회⁷⁾에서는 예방 치료가 필요한 편두통 환자는 기존 경구 예방약제 등의 의학적 치료에 높은 만족도를 보이지 못하는 상황이며, 기존 예방 약제에 실패한 치료 저항성 편두통 환자에서 유효성 및 안전성 프로파일 등의 임상적 유용성을 입증한 신청품이 임상 현장에서 필수적이고 환자들의 삶의 질 개선 등을 위해 급여의 필요성이 있다는 의견을 제시함.
- 아울러, 대한두통학회⁸⁾에서는 난치성 편두통은 기존 예방 치료요법의 효과가 불충분하며, 부작용의 발생으로 기존 예방 치료에 효과를 보지 못하여 심각한 예후를 보이는 질환이며, 신청품은 임상 현장에서 유용성을 입증하였고 편두통 환자 진료에 필수적이므로 신청품의 요양급여 필요성을 주장하는 의견서를 추가로 제출함.

○ 비용 효과성

- 국내 임상진료지침⁹⁾에서 ‘성인 편두통 환자의 예방치료’에 권고되는 등재의약품 중 ‘편두통 예방’에 허가받은 topiramate, divalproex, nadolol과 ‘중증의 난치성 편두통에 허가받은 flunarizine을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품의 1개월 투약비용은 ■■■■■원으로, 대체약제 1개월 투약비용인 ■■■■원 ~ ■■■■원 보다 고가임.
- 신청품은 위약(placebo) 대비 월 편두통 일수의 전체 평균 변화량에서 유의한 개선을 보인 점, 편두통 질병 특이적 도구(MSQ¹⁰⁾ 등)에서 삶의 질 개선이 관찰된 점 등을 근거로 경제성평가소위원회¹¹⁾에서 비용-효용분석 대상임이 확인되었으며, 검토결과 효용 추정의 불확실성을 고려한 ICER는 ■■■■■원/QALY로 비용효과비가 기존 유사 심의 결과¹²⁾ 범주 안에 포함되므로 수용가능함.

○ 재정 영향

- 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■■■■명이며, 제약사 제출 예상사용량¹³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁴⁾ 1차년도에 약 ■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■억원이 되고, topiramate, divalproex, flunarizine, nadolol 등의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■억원이 증가될 것으로 예상됨¹⁵⁾.

※ 신청품의 대상 환자수 및 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품 중 프리필드펜주는 A7 국가 중 미국, 일본, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국에, 프리필드시린지주는 미국, 일본 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022. Chapter 430: Migraine and Other Primary Headache Disorders.
- 2) Current Medical Diagnosis & Treatment. 2022. 24-01: Headache.
- 3) 편두통 예방치료 약제 진료지침. 2021. 대한두통학회. 대한신경과학회.
- 4) American Headache Society. The American Headache Society Position Statement On Integrating New Migraine Treatments Into Clinical Practice. Headache. 2019 Jan;59(1):1-18.
- 5) Mulleners WM, et al. Safety and efficacy of galcanezumab in patients for whom previous migraine preventive medication from two to four categories had failed (CONQUER): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3b trial. Lancet Neurol. 2020;19:814-25.
- 6) Detke HC, et al. Galcanezumab in chronic migraine: The randomized, double-blind, placebo-controlled REGAIN study. Neurology. 2018;91:e2211-21.
- 7) 대한두통학회(), 대한신경과학회()
- 8) 편두통 예방약제 급여 관련 대한두통학회 의견서()
- 9) 편두통 예방치료 약제 진료지침. 2021. 대한두통학회. 대한신경과학회.
- 10) Migraine-Specific Quality-of-Life Questionnaire
- 11) 2021년 제5차 경제성평가소위원회(2021.11.26.)
- 12) 암환자에 사용되는 약제 및 희귀질환 치료제를 제외한 만성질환 치료제의 위약 대비 경제성평가 급여 평가 심의사례
- 13) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: 펜·관, 2차년도: 펜·관, 3차년도: 펜·관)
- 14) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가
- 15) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량